外来でそのまま使える食事指導シリーズ

第1回 / 全10回

食事指導は「何を禁止するか」ではなく「何を守るか」から始める

外来で土台になる考え方を整理する

よくある食事指導

「血圧が高いので塩分を減らしましょう」

「血糖が高いので甘いものを控えましょう」

「コレステロールが高いので油ものはやめましょう」

間違いではないが、これだけでは食事指導はうまくいかない

食事指導がうまくいかない3つの理由

1

説明が抽象的

「塩分を控えて」→みそ汁は？漬物は？
「甘いものを控えて」→主食は減らすの？

2

制限ばかりが前に出る

「ダメなものを増やす話」になり
毎日のことなので長く続かない

3

低栄養の見落とし

制限が強すぎると高齢者・複数疾患で
体重減少・筋肉量低下を招く

食事は検査値だけでは決められない

年齢・体格・筋肉量・臓器機能・嚥下・生活背景を総合して「その人に合った食事」が見える

Case A: 制限の積み重ね

高血圧＋糖尿病＋肥満
→ 減塩＋糖質制限＋脂質制限
→ 制限が多すぎて続かない

Case B: 制限が逆効果

腎臓病＋食欲低下＋体重減少
→ たんぱく制限＋減塩
→ 低栄養が進行してしまう

食事指導の出発点

まず確認したい7つの項目

病気ごとの細かい話に入る前に、外来でまず見ておくべきこと

まず確認したい7つの項目

⚖️ 体重と体重変化	意図しない増減がないか
🧂 食塩の取り方	高血圧・腎臓病・心不全
🍱 食事量全体	多すぎ or 少なすぎ
🥩 たんぱく質の取り方	CKD vs フレイル・肝硬変
💧 水分の取り方	脱水 vs 心不全・腎障害
🍽️ 食形態	嚥下・咀嚼・術後の適合
🏠 生活背景	実行可能性の評価

① 体重と体重変化

単に「重いか軽いか」ではなく、ここ数か月での変化が重要

体重が増えている

・食事量の見直し
・間食・甘い飲み物の確認
・食べる速度・タイミング
・活動量との釣り合い

体重が減っている

・まず低栄養を疑う
・制限の前に「十分食べているか」
・高齢者・慢性疾患では特に注意
・筋肉量低下のサインを見る

② 食塩　③ 食事量　④ たんぱく質

🧂 食塩

自覚なく多いことが多い

隠れ塩分源:
・みそ汁、麺の汁
・漬物、練り物
・惣菜、弁当
・カップ麺

🍱 食事量全体

種類より総量が大事

確認すべき点:
・主食/主菜/副菜
・間食・夜食
・甘い飲み物
・アルコール

🥩 たんぱく質

一律に制限は危険

CKD → 制限が必要
高齢者 → 不足が問題
フレイル → 不足が問題
肝硬変 → 不足が問題
術後 → 不足が問題

⑤ 水分　⑥ 食形態　⑦ 生活背景

💧 水分

見落としやすい項目

脱水リスク:
・高齢者・下痢
・嚥下障害

制限が必要:
・心不全
・進行腎障害

🍽️ 食形態

安全に食べられるか

確認:
・嚥下障害の有無
・咀嚼力・入れ歯
・術後の食事制限
・少量頻回の必要性

🏠 生活背景

実行可能性が変わる

考慮すべき点:
・一人暮らし/調理力
・仕事の帰宅時間
・家族との食事
・買い物のしやすさ

制限だけの指導が危ない理由

📉 **糖尿病**	主食を極端に減らす → 食事量全体が落ちる
💪 **腎臓病**	たんぱく制限しすぎ → 筋肉量が落ちる
⚠️ **嚥下障害**	食べやすいものだけ → 水分・栄養不足

特に高齢者:「食べすぎ」より「食べなさすぎ」の方が深刻になることがある

食事指導で常に考える2つの軸

何を減らすべきか

・過剰な塩分
・過剰なカロリー
・病態に応じた制限
（たんぱく質、カリウム等）

何を不足させてはいけないか

・十分なエネルギー
・必要なたんぱく質
・水分
・ビタミン・微量栄養素

このバランスが崩れると、食事療法はうまくいかない

外来で使いやすい食事指導の進め方

1. **1回で変える項目は1〜2つに絞る**
   一度にたくさん → 続かない。具体的な行動目標1つから

2. **数字より行動に落とす**
   「減塩」→「みそ汁は1日1回」「麺の汁は残す」

3. **できていることを確認する**
   問題探しだけでなく、守れている点を評価 → 焦点が絞れる

4. **次回につながる指導にする**
   前回からの変化を確認。うまくいかなければ目標を再設定

具体的な行動目標の例

× 抽象的な指示

- 「塩分を控えてください」
- 「甘いものを控えてください」
- 「バランスよく食べてください」
- 「カロリーに気をつけて」

○ 具体的な行動

- 「みそ汁は1日1回に」
- 「毎日の缶コーヒーをやめる」
- 「麺の汁は半分残す」
- 「夜食の菓子パンをやめる」

栄養士につなぐべき場面

- 腎臓病で塩分・たんぱく質・カリウムの整理が必要
- 肝硬変で低栄養や筋肉量低下が気になる
- 消化管手術後で食事量が安定しない
- 嚥下障害があり食形態・水分調整が必要
- 複数の生活習慣病が重なり優先順位の整理が困難
- 高齢で体重減少・低栄養が疑われる

医師が方向性を示し、栄養士が生活に落とし込む — この連携が重要

このシリーズで扱うこと(全10回)

1. **総論(今回)**
   「何を守るか」から始める
2. **高血圧**
   減塩を中心に
3. **脂質異常症**
   脂質の「質」を考える
4. **糖尿病**
   食事全体の組み立て
5. **肥満**
   崩れにくい食べ方
6. **CKD**
   制限と低栄養予防の両立
7. **肝疾患**
   脂肪肝と肝硬変で真逆
8. **嚥下障害**
   食形態と安全な食べ方
9. **術後消化管**
   段階的な食事拡大
10. **フレイル**
    制限より「守る」優先順位

まとめ — Key Takeaways

- ✓ 食事指導は「禁止の列挙」ではなく「何を優先して守るか」を決めること
- ✓ まず7つの項目を確認：体重変化・食塩・食事量・たんぱく質・水分・食形態・生活背景
- ✓ 制限だけでは低栄養を招く — 「減らすもの」と「守るもの」の両方を考える
- ✓ 1回で変える目標は1～2つ、抽象的な指示ではなく具体的な行動に落とす
- ✓ 複雑な症例は栄養士と連携 — 医師が方向性、栄養士が生活に落とし込む

次回予告

第2回

高血圧の食事指導
― 減塩だけでは不十分な理由

チャンネル登録で見逃さないようにしましょう

ご視聴ありがとうございました

👍 高評価・チャンネル登録よろしくお願いします

📋 再生リストから他の回もご覧ください

💬 コメント欄で質問・リクエストお待ちしています

外来でそのまま使える食事指導シリーズ